EHCVM ou RGPH : quel IPM sert le mieux le PND 2026-2030 ?

Analyse comparative et recommandation

Pipeline `PythonIPM`

Septembre 2026

Résumé

Deux indices de pauvreté multidimensionnelle ont été calculés pour la Côte d'Ivoire sur l'année 2021 : l'un sur l'EHCVM, enquête auprès de 12 965 ménages, l'autre sur le RGPH, recensement exhaustif de 5,6 millions de ménages. Ce document les confronte au Plan National de Développement 2026-2030 et tranche : lequel est le plus aligné, lequel aide le mieux, et comment les employer ensemble. Il suppose connus les deux documents d'analyse qui le précèdent, mais peut se lire seul.

La recommandation en une page

L'IPM EHCVM est le plus aligné sur le *contenu* des cibles du PND, pour une raison qui tient en une ligne : le recensement ne pose aucune question de santé. L'assurance maladie et le renoncement aux soins lui échappent entièrement, et avec eux les cibles santé du Pilier 4. Il porte en outre la consommation, donc la pauvreté monétaire. Si un seul indice devait tenir le cadre de résultats, c'est celui-là.

Mais l'IPM RGPH est celui qui aide le mieux à agir : il est seul à rendre opérationnels trois instruments centraux du plan — les Pôles Économiques Compétitifs, le registre social unifié et le ciblage des 827 000 ménages de filets sociaux — que l'enquête ne peut pas servir du tout.

La recommandation n'est donc pas de choisir, mais de répartir les rôles :

- l'**EHCVM** tient le cadre de résultats — la valeur 2021, la cible 2030, les points d'étape ;
- le **RGPH** tient la carte et le registre — où investir, quels ménages servir ;
- la **variante harmonisée** fait le pont, et le fait bien : à indicateurs identiques, les deux sources donnent $M_0 = 0{,}2737$ et $0{,}2680$, soit 2 % d'écart.

Table des matières

1 Deux questions, pas une **2**

2 Couverture des cibles du PND **2**

2.1 Le décompte 2

2.2 Les cibles que l'une seule mesure 3

3 La finesse territoriale : l'écart est massif **4**

4 Le suivi dans le temps : l'écart est tout aussi massif, en sens inverse **4**

5 Ce que les deux mesurent également bien **4**

5.1 Le test de cohérence : la variante harmonisée 5

6 Le verdict **5**
6.1 Lequel est le plus aligné ? 5
6.2 Lequel aide le mieux ? 6

7 Architecture recommandée **6**
7.1 Les trois rôles 6
7.2 Ce qu'il reste à faire 6

8 Limites de cette comparaison **7**

1 Deux questions, pas une

Le PND 2026-2030 pose au statisticien deux questions de nature différente, et l'essentiel de la comparaison tient à ce qu'aucune source ne répond bien aux deux.

Mesurer.
Où en est-on, et où en sera-t-on en 2030 ? Le plan fixe des cibles chiffrées, pilier par pilier, avec une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Y répondre demande un indicateur dont le contenu recoupe ces cibles, et qui puisse être recalculé en cours de plan.

Cibler.
Où faut-il investir, et quels ménages faut-il servir ? Le Pilier 5 veut une « cartographie fine » pour ses Pôles Économiques Compétitifs, le Pilier 6 un « registre social unifié », le Pilier 4 une liste de 827 000 ménages. Y répondre demande une base exhaustive, ou au moins une maille territoriale très fine.

Le partage naturel

Une enquête par sondage est faite pour mesurer : questionnaire long, indicateurs riches, répétée dans le temps. Un recensement est fait pour dénombrer : questionnaire court, indicateurs pauvres, mais exhaustif et localisé. Le PND a besoin des deux, et la comparaison qui suit ne fait que le chiffrer.

2 Couverture des cibles du PND

2.1 Le décompte

Vingt-deux cibles et orientations du PND peuvent être éclairées par un indice de pauvreté. Le tableau ci-dessous en donne la couverture par source.

Nature de la prise	EHCVM	RGPH
Directe	11	7
Approchée	0	2
Indirecte	3	2
Partielle	2	0
Opérationnelle (ciblage)	0	3
Aucune	6	8

Ce tableau flatte l'EHCVM, et il faut savoir pourquoi

Il compte des *cibles*, or plusieurs cibles retombent sur le *même* indicateur : les deux cibles d'analphabétisme sur l'indicateur d'alphabétisation, les deux cibles de couverture sociale sur l'indicateur d'assurance maladie. En **indicateurs distincts** à prise directe, le compte passe de 11 contre 7 à **9 contre 6**.
Il récompense en outre mécaniquement la source la mieux dotée : l'EHCVM porte seize indicateurs, le RGPH treize. Ce n'est pas un résultat, c'est une propriété du questionnaire.
L'écart réel se ramène à trois indicateurs : l'assurance maladie, le renoncement aux soins, et l'année de scolarité mesurée exactement plutôt qu'approchée par le diplôme. Deux sur trois sont des indicateurs de santé — c'est là, et seulement là, que se joue l'avantage de l'enquête.

2.2 Les cibles que l'une seule mesure

C'est là que se joue l'essentiel. Onze cibles sont couvertes par une source et pas par l'autre : sept par la seule EHCVM, quatre par le seul RGPH.

Cible ou orientation du PND	EHCVM	RGPH
Enrôlés à la CMU de 20 à 30 millions (P. 4)	**oui**	non
Protection sociale de 27 à 50 % (P. 4)	**oui**	non
Population à moins de 5 km d'un centre de santé, 82 à 100 % (P. 4)	**oui**	non
Retard de croissance des moins de 5 ans, 21,4 à 18 % (P. 4)	**oui**	non
Désagrégation par sexe du chef de ménage (P. 4)	**oui**	non*
Habitat décent : densité d'occupation (P. 5)	**oui**	non
Croisement avec la pauvreté monétaire (objectif général)	**oui**	non
Espérance de vie de 62,3 à 65 ans (P. 4)	non	**oui**
Pôles Économiques Compétitifs, villes secondaires (P. 5)	non	**oui**
Registre social unifié pour le ciblage (P. 6)	non	**oui**
827 000 ménages bénéficiaires des filets sociaux (P. 4)	non	**oui**

*Le sexe est absent de l'*extrait* RGPH transmis, non du recensement : la numérotation des questions y passe de P16 à P18, la question P17 manquant. Une demande à l'INS lèverait cette limite. Et dans les deux sources, désagréger par sexe du chef de ménage éclaire la cible « indice de l'écart genre » sans la mesurer — c'est un indice composite couvrant l'emploi, l'éducation, la santé et la représentation politique.

Lecture

L'EHCVM gagne sur le **contenu** du Pilier 4 : les cibles santé et nutrition, que le recensement ne peut pas approcher parce qu'il ne pose aucune question de santé.
Le RGPH gagne sur les **instruments** des Piliers 5 et 6 : la cartographie, le registre, le ciblage — trois orientations qui ne sont pas des cibles chiffrées mais des dispositifs à construire, et qu'une enquête par sondage ne peut pas alimenter.

3 La finesse territoriale : l'écart est massif

Le Pilier 5 entend « une répartition optimale et équitable des investissements publics et privés » fondée sur une « cartographie fine ». La question est donc : à quelle maille chaque source produit-elle un chiffre publiable ?

Convention usuelle : une estimation dont le coefficient de variation dépasse 20 % n'est pas publiable.

	EHCVM		RGPH	
Maille	**Modalités**	**Non publ.**	**Modalités**	**Non publ.**
Région	33	0	33	0
Département	108	15	111	**0**
Sous-préfecture ou commune	442	**92**	519	**19**

Le chiffre qui tranche le Pilier 5

Les 92 sous-préfectures non publiables de l'EHCVM représentent **47,9 % de la population** ivoirienne. Les 19 du RGPH en représentent **1,55 %**.
Autrement dit : fonder une allocation d'investissements à la maille de la sous-préfecture sur l'EHCVM reviendrait à ne rien pouvoir dire, de façon publiable, sur la moitié du pays. Le recensement ramène cette zone d'ombre à un cinquantième.

Le coefficient de variation médian donne la même lecture en continu : 15,4 % contre 9,0 % à la sous-préfecture, 12,3 % contre 5,0 % au département.

4 Le suivi dans le temps : l'écart est tout aussi massif, en sens inverse

Le recensement ne dira pas si le PND a réussi

Le RGPH est décennal : le prochain n'interviendra pas avant la fin du plan. L'IPM RGPH fournit une valeur de départ, très détaillée, mais aucune évolution. **Ce point est certain.**
L'EHCVM est une enquête répétée — 2018, puis 2021. Le rythme passé laisse attendre une vague dans l'intervalle du plan, mais **aucune programmation n'a été vérifiée ici** : l'argument « seule l'EHCVM permettra le suivi » suppose cette vague et doit être confirmé auprès de l'INS avant d'être avancé devant une instance de décision.

Pour un plan quinquennal assorti de cibles datées, c'est un argument qui ne se compense pas : un indice qu'on ne peut recalculer qu'une fois n'est pas un indicateur de suivi.

5 Ce que les deux mesurent également bien

Sept indicateurs sont communs aux deux sources avec une définition quasi identique. Les taux de privation se suivent de près, ce qui valide les deux calculs l'un par l'autre.

Indicateur	EHCVM	RGPH	Commentaire
Année de scolarité	62,9 %	63,2 %	le diplôme approche bien les années d'études
Énergie de cuisson	66,3 %	62,7 %	—
Emploi de subsistance	40,5 %	46,0 %	approximation côté RGPH
Fréquentation scolaire	31,9 %	35,6 %	—
Biens d'équipement	21,7 %	18,2 %	le RGPH mesure les 8 biens, l'EHCVM 7
Logement	17,3 %	25,0 %	nomenclatures de matériaux différentes
Électricité	9,3 %	11,5 %	—
Chômage	6,5 %	5,9 %	—
Eau potable	20,9 %	14,3 %	le RGPH perd le temps de trajet
Toilette	67,2 %	45,1 %	le RGPH perd le partage des sanitaires
Alphabétisation	62,9 %	70,4 %	—
État civil	26,3 %	15,2 %	—

5.1 Le test de cohérence : la variante harmonisée

Le pipeline produit, pour chaque source, une variante restreinte au socle des douze indicateurs communs. C'est la seule comparaison légitime entre les deux.

	H	A	M_0
EHCVM 2021	53,5 %	0,5113	**0,2737**
RGPH 2021	52,0 %	0,5157	**0,2680**

Un résultat qui compte pour le PND

À indicateurs identiques, une enquête par sondage et un recensement exhaustif, collectés la même année par deux dispositifs entièrement différents, donnent **2 % d'écart**.
Conséquence pratique : la carte territoriale du recensement et le tableau de bord de l'enquête peuvent être utilisés *ensemble* sans craindre qu'ils racontent deux histoires différentes. C'est ce qui rend l'architecture recommandée ci-dessous opérationnelle et non seulement théorique.

6 Le verdict

6.1 Lequel est le plus aligné ?

L'IPM EHCVM, et pour trois raisons qui se cumulent.

1. **Il couvre le cœur du Pilier 4**, le pilier du capital humain, où se concentrent les cibles sociales du plan. Les cibles santé et nutrition — CMU, protection sociale, accès aux soins — sont hors de portée du recensement, qui ne pose aucune question de santé. **C'est l'argument principal, et le seul qui soit hors de discussion.**
2. **Il porte la consommation**, donc permet de croiser pauvreté monétaire et multidimensionnelle — ce que l'objectif général du plan appelle, et que le recensement ne permet pas.
3. **Il est actualisable en principe**, étant une enquête répétée, là où le recensement décennal ne le sera pas avant 2031. Le calendrier précis de la prochaine vague reste à confirmer.

Un quatrième argument est souvent avancé — « il couvre onze cibles contre sept » — mais il ne résiste pas à l'examen : ramené aux indicateurs distincts, l'écart est de neuf contre six, et il se réduit aux trois indicateurs cités plus haut.

6.2 Lequel aide le mieux ?

Cela dépend de ce qu'on appelle aider, et la réponse honnête est qu'ils aident à deux moments différents du cycle de la politique publique.

Moment	Ce que le PND demande	Source
Cadrer	fixer la cible de pauvreté à 2030, que le plan a laissée en blanc	EHCVM
Répartir	allouer les investissements du Pilier 5 entre territoires	**RGPH**
Cibler	constituer le registre social unifié, servir 827 000 ménages	**RGPH**
Suivre	mesurer les progrès à mi-parcours et en 2030	EHCVM
Rendre compte	documenter l'atteinte des cibles du cadre de résultats	EHCVM

Ce que choisir une seule source coûterait

Ne garder que l'EHCVM : le Pilier 5 perdrait sa base statistique — près de la moitié de la population dans une zone dont l'IPM n'est pas publiable — et le registre social unifié du Pilier 6 devrait être construit sans information de privation.
Ne garder que le RGPH : le plan perdrait toute mesure de la santé, de la nutrition, de la protection sociale et du genre, c'est-à-dire la plus grande partie des cibles sociales du Pilier 4, et n'aurait aucun moyen de constater ses progrès avant 2031.

7 Architecture recommandée

7.1 Les trois rôles

L'EHCVM tient le cadre de résultats.
$M_0 = 0{,}2863$ en 2021 devient la valeur de départ ; une cible 2030 est fixée, comblant la seule absence de valeur chiffrée parmi les objectifs majeurs du plan ; onze cibles sectorielles sont suivies sur une série unique et cohérente plutôt que sur onze statistiques éparses.

Le RGPH tient la carte et le registre.
Un IPM publiable pour 111 départements et 500 sous-préfectures fonde la planification spatiale du Pilier 5. Les 5,6 millions de ménages, dont 1 751 746 pauvres et 285 115 en pauvreté sévère, chacun avec son score et sa localisation, fondent le registre social du Pilier 6 et le ciblage des filets sociaux.

La variante harmonisée fait le pont.
Elle garantit que les deux instruments parlent de la même chose. Elle sert aussi de contrôle : si un futur IPM EHCVM s'écartait fortement de la trajectoire, la comparaison harmonisée dirait s'il s'agit d'un effet réel ou d'un artefact de mesure.

7.2 Ce qu'il reste à faire

1. **Faire adopter une cible d'IPM à 2030** dans le cadre de gouvernance du PND. C'est la seule action qui transforme un travail statistique en instrument de pilotage.
2. **Publier la carte RGPH** à la maille du département et de la sous-préfecture, en signalant les 19 sous-préfectures non publiables.
3. **Arbitrer les deux points méthodologiques ouverts** avant toute publication : le taux de privation de la toilette au RGPH, non réconcilié avec la production Stata antérieure, et l'approximation de l'emploi agricole de subsistance, qui porte à elle seule 26,8 % de l'indice RGPH.

4. **Reprendre le croisement monétaire / multidimensionnel** sur la méthode officielle de calcul du taux de pauvreté, pour documenter l'objectif général du plan.
5. **Prévoir le recalcul de l'IPM EHCVM** sur la prochaine vague d'enquête, aux mêmes définitions — le pipeline le permet sans modification.

8 Limites de cette comparaison

1. **Le décompte des cibles est un jugement, pas une mesure**, et il est biaisé en faveur de la source la mieux dotée en indicateurs. Classer une prise en « directe », « approchée » ou « indirecte » suppose d'apprécier la proximité entre un indicateur de ménage et une cible souvent formulée en taux individuel. C'est pourquoi la conclusion de ce document ne repose pas sur ce décompte mais sur l'absence de module de santé au recensement, qui est un fait.
2. **Le PND ne contient aucune cible d'IPM.** L'alignement établi ici est un alignement de contenu. Rien dans le plan n'engage à retenir cet indice.
3. **Les deux IPM complets ne sont pas comparables en niveau**, la dimension Santé du RGPH étant presque inerte. Toutes les comparaisons de niveau de ce document passent par la variante harmonisée.
4. **Les cibles du PND ont des années de référence hétérogènes** (2021, 2023, 2024, 2025) alors que les deux IPM sont datés de 2021. Les écarts à la cible ne sont donc pas des écarts à la valeur de départ officielle.